COMPLEMENTO OFICIAL #3 · AVALIAÇÃO & DOCUMENTAÇÃO

KIT CLÍNICO PRO: 25 TESTES ORTOPÉDICOS + FICHAS DE AVALIAÇÃO

Guia Rápido dos 25 Testes Ortopédicos Mais Usados por Região Corporal,
Ficha de Avaliação Ortopédica Completa e Termo de Consentimento para Eletroterapia

O QUE ENCONTRAS NESTE GUIA PRÁTICO:

- ✓ **25 Testes Ortopédicos Essenciais por Articulação**
  Execução passo a passo, o que indica o teste positivo e com qual Mapa de Elétrodos cruzar.
- ✓ **Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca**
  Spurling, Lasègue, Slump Test, Patrick-FABER e Gaenslen explicados de forma direta.
- ✓ **Ombro, Cotovelo, Punho e Mão**
  Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe, Cozen, Mill, Phalen e Finkelstein para diagnóstico funcional.
- ✓ **Anca, Joelho, Tornozelo e Pé**
  Thomas, Ober, Lachman, Gaveta, McMurray, Thompson e Gaveta Anterior do Tornozelo.
- ✓ **Ficha de Avaliação + Termo de Consentimento Informado**
  Modelos prontos a imprimir para blindar o teu registo clínico e jurídico.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição Digital em Alta Definição · 10 Páginas · Pronto para Consulta no Telemóvel, Tablet ou Impressão

1. Testes Ortopédicos — Ombro (Coifa dos Rotadores e Impacto)

Confirmação funcional rápida antes de selecionar o Mapa de Elétrodos do Ombro.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Jobe (Empty Can)	Tendão Supraespinhoso	Abdução 90° no plano da escápula + rot. interna contra resistência -> Dor/	Mapa Ombro — Supraespinhoso / Coifa
Teste de Neer	Impacto Subacromial / Bursa	Elevação passiva máxima do braço em rotação interna com escápula estab	Mapa Ombro — Analgesia Global (Cruzada)
Hawkins-Kennedy	Impacto Subacromial	Ombro e cotovelo a 90°; realizar rotação interna passiva/forçada -> Dor su	Mapa Ombro — Face Anterior/Lateral
Teste de Gerber (Lift-off)	Músculo Subescapular	Dorso da mão na região lombar; afastar a mão das costas contra resistênc	Mapa Escápula / Ombro Posterior
Teste de Speed (Palm-up)	Cabo Longo do Bíceps	Flexão anterior do ombro com cotovelo estendido e antebraço supinado ->	Mapa Ombro Anterior / Bíceps Braquial
Teste de Apreensão	Instabilidade Anterior	Abdução 90° + rotação externa máxima em decúbito dorsal -> Receio de l	Mapa Reforço Deltoide / Estabilizadores

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sempre avalie primeiro o lado assintomático para estabelecer o padrão de força e amplitude basal do paciente.

2. Testes Ortopédicos — Cotovelo, Punho e Mão

Diferenciação rápida entre epicondilites, tenossinovites e compressões nervosas.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Cozen	Epicondilite Lateral	Punho em extensão radial contra resistência com cotovelo a 90° -> Dor no	Mapa Cotovelo — Epicondilite Lateral
Teste de Mill	Extensores do Carpo	Alongamento passivo: pronação + flexão do punho + extensão do cotovelo	Mapa Antebraço Dorsal / Extensores
Cotovelo de Golfista	Epicondilite Medial	Flexão palmar do punho contra resistência e supinação -> Dor no epicôndi	Mapa Cotovelo — Epicondilite Medial
Teste de Finkelstein	Tenossinovite De Quervain	Polegar fechado dentro dos outros dedos + desvio ulnar passivo -> Dor est	Mapa Punho Radial / Polegar
Teste de Phalen	Síndrome Túnel Cárpico	Flexão máxima de ambos os punhos (dorso com dorso) por 60 segundos ->	Mapa Punho / Canal Cárpico (TENS)
Sinal de Tinel no Punho	Nervo Mediano	Percussão leve sobre o retináculo dos flexores -> Choque irradiado para os	Mapa Antebraço Ventral / Punho

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Quando Phalen e Tinel forem positivos com perda de força de pinça tenar, priorize TENS convencional (sensorial suave) e evite co

3. Testes Ortopédicos — Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca

Triagem de radiculopatias, dor facetária e disfunção sacroilíaca.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Spurling	Compressão Radicular Cervical	Inclinação lateral + extensão da cabeça + compressão axial leve -> Dor irr	Mapa Cervical + Trapézio Superior
Teste de Tração Cervical	Alívio Radicular / Facetário	Tração manual cefálica suave em decúbito dorsal -> Alívio imediato da dor	Mapa Cervical Paravertebral Bilateral
Teste de Lasègue (SLR)	Nervo Ciático / Raiz L4–S1	Elevação da perna estendida em decúbito dorsal -> Dor radicular entre 30	Mapa Ciatalgia (Lombar + Glúteo/Coxa)
Slump Test	Tensão Neural Neuroeixo	Sentado: flexão dorsal + cervical + extensão de joelho + dorsiflexão -> Re	Mapa Lombar Baixa + Trajeto Ciático
Patrick (FABER)	Anca vs. Artic. Sacroilíaca	Flexão + Abdução + Rot. Externa (4) -> Dor inguinal (Anca) ou posterior (S	Mapa Sacroilíaca ou Região Glútea
Teste de Kemp	Dor Facetária Lombar	Extensão + rotação + inclinação ipsilateral em pé -> Dor localizada parave	Mapa Lombar Cruzado (4 Elétrodos)

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sinal de Alerta (Red Flag): perda progressiva de força motora (pé caído) ou alterações esfincterianas (cauda equina) exigem enca

4. Testes Ortopédicos — Anca e Coxa

Avaliação de encurtamentos musculares, impacto femoroacetabular e síndrome do piriforme.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Thomas	Contratura Iliopsoas / Reto Fem	Abraçar um joelho ao peito em decúbito dorsal -> Coxa oposta sobe da ma	Mapa de Coxa Anterior / Quadríceps
Teste de Ober	Trato Iliotibial / TFL	Decúbito lateral: abduzir e estender a anca e deixar cair em adução -> Cox	Mapa Lateral da Coxa / Trocânter
Teste de FADDIR	Impacto Femoroacetabular	Flexão 90° + Adução + Rotação Interna passiva da anca -> Dor profunda n	Mapa Anca / Região Glútea
Teste de FAIR (Piriforme)	Síndrome do Piriforme	Decúbito lateral: Flexão 60° + Adução + Rotação Interna -> Dor no glúteo/	Mapa Glúteo Profundo / Piriforme
Trendelenburg	Força do Glúteo Médio	Apoio unipodal -> Queda da hemipelve contralateral (fraqueza abdutora	Mapa NMES Glúteo Médio (Reforço)
Teste de Ely	Encurtamento Reto Femoral	Decúbito ventral: flexão passiva do joelho -> Elevação compensatória da p	Mapa Reto Femoral + Vastos

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

No Trendelenburg positivo, utilize o Mapa de Glúteo Médio em modo NMES/FES associado ao agachamento unipodal assistido para

5. Testes Ortopédicos — Joelho, Tornozelo e Pé

Avaliação ligamentar, meniscal e tendínea do membro inferior.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Lachman	Lig. Cruzado Anterior (LCA)	Joelho a 20–30°: translação anterior da tíbia sobre o fémur -> Fim de curso	Mapa NMES Vasto Medial Oblíquo (VMO)
Teste de McMurray	Menisco Medial e Lateral	Flexão máxima + rotação externa (medial) ou interna (lateral) + extensão	Mapa Joelho Peripatelar (4 Elétrodos)
Apreensão Patelar	Instabilidade Femoropatelar	Deslocamento lateral passivo da rótula com joelho a 30° -> Contração de q	Mapa Reforço Seletivo VMO + Reto Fem
Gaveta Anterior Tornozelo	Lig. Talofibular Anterior	Pé em leve flexão plantar: puxar calcâneo anteriormente -> Translação exc	Mapa Tornozelo Lateral / Fibulares
Teste de Thompson	Integridade Tendão Aquiles	Decúbito ventral: compressão manual da barriga dos gémeos -> Ausência	Mapa Gémeos / Tendão de Aquiles
Teste de Windlass	Fascite Plantar	Extensão passiva da 1ª metatarsofalângica em carga -> Dor na inserção ca	Mapa Planta do Pé / Arco Medial

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Se o Teste de Thompson for positivo (suspeita de rotura total do tendão de Aquiles), NÃO aplique eletroestimulação motora nos ge

6. Escala Visual Analógica (EVA) e Seleção da Corrente Ideal

Como cruzar a nota de dor (0 a 10) e o objetivo funcional com a corrente correta nos Mapas.

Nível de Dor / Fase	Corrente de 1ª Escolha	Frequência / Pulso	Tempo e Sensação Alvo
EVA 8 a 10 (Dor Aguda)	TENS Convencional (Portão)	80 a 120 Hz · 50 a 100 µs	20 a 30 min · Formigueiro intenso e confortável
EVA 5 a 7 (Subaguda)	TENS VIF ou Modulado	4 a 100 Hz · 100 a 150 µs	25 min · Evita acomodação neural durante a ses
EVA 3 a 6 (Dor Crónica)	TENS Burst / Acupuntura	2 a 4 Hz · 180 a 250 µs	25 a 30 min · Abalos rítmicos visíveis para libert
Inibição Artrogénica (Pós-Op)	NMES (FES) Sincronizado	35 a 50 Hz · 250 a 300 µs	ON 6s / OFF 12s · Contração visível associada ac
Hipotrofia Muscular	Corrente Russa ou Aussie	Aussie 1kHz / 50Hz	ON 8s / OFF 16s · 15 a 20 min · Contração forte
Edema Localizado	NMES Bomba Muscular	10 a 20 Hz · 200 µs	Recíproco ou rítmico 15 min com membro eleva

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Registe sempre a EVA antes e imediatamente após a sessão na Ficha de Evolução para comprovar a eficácia analgésica ao pacien

7. Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Estruturada (Modelo Imprim

Roteiro completo de anamnese, exame físico e planeamento eletroterapêutico.

Bloco da Avaliação	Campos a Preencher na Consulta Inicial	Objetivo do Registo	Frequência
1. Identificação e Queixa	Nome, idade, profissão, desporto, Queixa Principal (QP) e tempo de evolução	Contextualizar sobrecarga	1ª Sessão
2. Triagem de Segurança	Pacemaker? Gestante? Epilepsia? Neoplasia? Implantes metálicos? Alteração de sensibilidade?	Descartar contraindicações absolutas	Obrigatório 1ª Sessão
3. Mapa da Dor e EVA	Localização exata, irradiação, EVA em repouso (0–10) e EVA ao movimento (0–10)	Linha de base mensurável	Todas as sessões
4. Exame Físico	ADM ativa/passiva, Força Muscular (Grau 0 a 5 MRC) e Testes Ortopédicos Positivos	Diagnóstico cinético-funcional	A cada 5 sessões
5. Plano Eletroterapêutico	Mapa nº escolhido, Corrente, Frequência (Hz), Largura (µs), Canais (CH1–CH4) e Tempo	Padronizar atendimento na clínica	Todas as sessões
6. Conduta Associada	Cinesioterapia, terapia manual, orientações domiciliares e meta da semana	Garantir resolução da causa raiz	Todas as sessões

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Podes imprimir esta estrutura ou preenchê-la digitalmente no tablet junto com a Ficha de Evolução do Paciente.

8. Termo de Consentimento Informado para Eletroterapia (Modelo

Texto padrão para assinatura do paciente no início do tratamento fisioterapêutico.

Cláusula do Termo	Texto de Referência para o Paciente	Confirmação	Validade
1. Natureza do Procedimento	Declaro que fui informado(a) sobre a aplicação de recursos de eletrotermofototerapia (TENS, NMES, U	[ ] Ciente	Todo o plano
2. Questionário de Segurança	Confirmo que informei ao fisioterapeuta se possuo pacemaker, gravidez, implantes, epilepsia ou perd	[ ] Confirmado	Obrigatório
3. Sensação Esperada	Compreendo que deverei comunicar imediatamente qualquer sensação de ardor, choque desconfortá	[ ] Ciente	Cada sessão
4. Higiene e Cuidados da Pele	Fui orientado(a) a não comparecer com cremes oleosos na região e autorizo a higienização prévia do	[ ] Autorizado	Cada sessão
5. Assinatura do Paciente	Nome Legível: ____________________ Data: ___/___/20___ Assinatura: ________________	Documento assinado	Arquivo clínico

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Manter o Termo de Consentimento assinado e o questionário de contraindicações preenchido protege o profissional e transmite al

9. Guia de Integração Total: Avaliação -> Mapa de Elétrodos -> Alt

Fluxo de trabalho em 5 passos para sessões mais rápidas, seguras e padronizadas.

Passo do Fluxo	Ação Prática na Sessão (Tempo Estimado)	Ferramenta do Kit	Resultado Clínico
Passo 1 (2 min)	Aplicar 1 ou 2 Testes Ortopédicos específicos + medir EVA (0-10)	Páginas 2 a 6 deste Guia	Alvo anatômico confirmado
Passo 2 (30 seg)	Abrir os +50 Mapas Visuais na região correspondente	+50 Mapas Visuais Principais CH1/CH2	Zero dúvida no posicionamento
Passo 3 (1 min)	Ajustar Hz, µs e tempo conforme a fase aguda/subaguda/crônica	Guia Rápido de Parâmetros	Dose eletrofisiológica exata
Passo 4 (15–25 min)	Executar aplicação (isolada ou associada a exercício ativo / Laser / US)	Guias de Ultrassom e Laser	Máxima eficácia terapêutica
Passo 5 (1 min)	Anotar parâmetros usados e EVA final	Ficha de Evolução do Paciente	Histórico impecável para a próxima sessão

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Com este ecossistema completo, tens em mãos toda a referência visual de Eletroterapia, Ultrassom, Laserterapia e Avaliação Orto